

ĐAU DO UNG THƯ

1. ĐẠI CƯƠNG

Ung thư là bệnh lý ác tính trong đó tế bào ung thư phát triển vô hạn độ, vô tổ chức, không tuân theo các cơ chế kiểm soát của cơ thể. Đặc điểm của bệnh ung thư là xâm lấn, di căn và hay tái phát. Khi mắc bệnh ung thư, người bệnh không chỉ bị tổn thương thực thể mà còn bị tổn thương cả về tinh thần, tâm lý. Ở bệnh nhân ung thư, 90% có dấu hiệu mệt mỏi, 80% có sút cân, chán ăn, lo lắng hốt hoảng và 80-85% có biểu hiện đau ở các mức độ khác nhau.

Đau là một cảm nhận thuộc về giác quan và xúc cảm do tổn thương đang tồn tại hoặc tiềm tàng ở các mô gây nên và phụ thuộc vào độ nặng nhẹ của tổn thương.

Điều trị ung thư ngoài những điều trị đặc hiệu nhằm mục đích tiêu diệt tổn thương ung thư cần phải điều trị những triệu chứng cơ năng, thực tổn và các rối loạn về tâm lý, đặc biệt là triệu chứng đau nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào hỏi bệnh, quan sát nét mặt, hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.

2.2. Phân loại đau

– Đau do kích thích quá mức: tổn thương mô nhưng không có tổn thương thần kinh, hệ thống dẫn truyền đau từ ngoại vi đến trung ương vẫn nguyên vẹn. Điều trị bằng cách loại bỏ hoặc hạn chế kích thích đau, cắt đứt thông tin đau.

– Đau do tổn thương thần kinh: cơ chế đau là do thần kinh. Điều trị bằng các thuốc chống đau thông thường ít hiệu quả cần phối hợp thêm các thuốc thần kinh khác (an thần, chống trầm cảm).

– Đau do kích thích đầu mút tận cùng thần kinh: đau nội tạng bị tổn thương, thường kèm theo các biểu hiện rối loạn thần kinh tự động.

– Đau do căn nguyên tâm lý: đau không điển hình, khám không thấy có tổn thương thực thể.

Trên thực tế đau do ung thư là do phối hợp nhiều cơ chế từ những tổn thương thực thể phối hợp với các rối loạn chức năng và tâm lý.

2.3. Chẩn đoán nguyên nhân

Đau trong bệnh lý ung thư có thể do các nguyên nhân sau:

- Xâm lấn phá huỷ tổ chức xung quanh.
- Chèn ép, huỷ hoại các dây thần kinh hoặc đám rối thần kinh.
- Xâm nhiễm phá huỷ xương, tổn thương màng xương.
- Xâm nhiễm, viêm loét, hoại tử niêm mạc.
- Xâm lấn chèn ép vào cơ quan phủ tạng gây đau căng tức.
- Xâm lấn vào các cấu trúc màng (màng não, màng tim, màng phổi, bao gan, bao lách...).
- Chèn ép các ống bài xuất của gan, thận, tụy...
- Chèn ép bạch mạch, mạch máu có thể kèm huyết khối hoặc không.
- Ngoài ra còn phải kể đến đau là do các rối loạn chức năng khác như táo bón, bí tiểu, co cứng cơ, viêm loét thoái hóa do nằm lâu...

Trong thực tế, đứng trước một bệnh nhân ung thư than phiền về đau, có thể gặp các tình huống sau đây:

- Đau là triệu chứng khởi đầu giúp phát hiện ra bệnh ung thư.
- Đau gắn liền với diễn biến của một bệnh ung thư đã biết.
- Đau do di chứng của bệnh ung thư đã được điều trị.
- Đau không liên quan đến bệnh ung thư mà là do các nguyên nhân khác.

Chẩn đoán đau do ung thư di căn xương:

Trên lâm sàng, di căn xương là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau ở bệnh nhân ung thư. Triệu chứng đau do ung thư di căn xương có thể xuất hiện rất sớm trên xạ hình xương, PET/CT, trước khi có biểu hiện lâm sàng. Bệnh nhân có chẩn đoán xác định bệnh ung thư nguyên phát bằng mô bệnh học cần phải làm các xét nghiệm đánh giá chung để xác định tổn thương di căn, giúp phân loại giai đoạn bệnh chính xác để lựa chọn phương pháp điều trị đúng.

- Các xét nghiệm cần làm:

+Định lượng calci, phosphatase kiềm (ALP): nồng độ tăng cao trong máu.

+Chụp Xquang, CT, MRI tại vị trí đau: thường thấy hình ảnh tổn thương cấu trúc xương.

+Chụp xạ hình xương với ^{99m}Tc -MDP trên máy gamma camera, SPECT, SPECT/CT: là kỹ thuật quét toàn thân, hiện hình toàn bộ khung xương. Hình ảnh tổn thương xương có thể là dạng tăng tập trung hoạt độ phóng xạ do tăng hoạt động tái tạo xương nơi tổn thương, hình ảnh di căn cũng có thể là hình giảm hoặc khuyết hoạt độ phóng xạ do tại tổn thương di căn hiện tượng tiêu hủy xương chiếm ưu thế.

+Chụp PET, PET/CT với ^{18}F -FDG: là kỹ thuật chụp hình chuyển hóa, có độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao. Hình ảnh PET/CT do ung thư di căn xương thường là những ổ tăng hấp thu, chuyển hóa FDG.

+Các tổn thương do ung thư di căn vào xương trên hình ảnh y học hạt nhân xuất hiện rất sớm, khi xương chưa có tổn thương cấu trúc và có thể thấy trước hình ảnh tổn thương xương trên film Xquang 3-6 tháng.

+Những trường hợp nghi ung thư di căn xương mà hình ảnh không điển hình cần phải sinh thiết xương định vị dưới hướng dẫn của hình ảnh để có chẩn đoán xác định.

3. ĐIỀU TRỊ ĐAU DO UNG THƯ

Đau trong ung thư không chỉ là đau thuần túy về thể xác mà là chứng đau tổng hợp tâm - thể phức tạp dẫn đến trạng thái lo âu trầm cảm nặng nề. Bởi vậy, người thầy thuốc phải nghiên cứu kỹ, chẩn đoán chính xác thì điều trị mới hiệu quả. Điều trị đau do ung thư bao gồm điều trị nguyên nhân gây đau (điều trị ung thư) và điều trị triệu chứng (điều trị chống đau).

3.1. Điều trị nguyên nhân gây đau

Áp dụng các phương thức điều trị ung thư nói chung, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị các liệu pháp sinh học, miễn dịch, hormon. Tùy loại ung thư, giai đoạn bệnh, khả năng và điều kiện có thể mà áp dụng các phương thức điều trị nói trên. Để đạt được hiệu quả cao ngăn ngừa tái phát, di căn cần phối hợp đa phương thức trong điều trị.

3.2. Điều trị chống đau do ung thư

3.2.1. Nguyên tắc điều trị đau

- Tôn trọng và tiếp nhận những than phiền đau của bệnh nhân.
- Đánh giá chính xác mức độ đau và các triệu chứng khác kèm theo.
- Lựa chọn phác đồ điều trị đau phù hợp.
- Điều trị những rối loạn khác nếu có đồng thời với việc điều trị đau.
- Phối hợp đa phương thức để điều trị.
- Luôn chú ý kết hợp tâm lý liệu pháp trong điều trị đau do ung thư.

Điều trị đau do ung thư cần phải có chiến lược cụ thể, dựa trên việc sử dụng đồng thời và từng mức độ những kỹ thuật điều trị sao cho phù hợp với sự cần thiết của mỗi bệnh nhân. Chi tiết của từng phương pháp có thể thay đổi rất khác nhau tùy mỗi trường hợp bệnh nhân cụ thể. Điều trị chống đau do ung thư cần đạt được mục tiêu sau:

- Tăng thời gian ngủ được không đau.
- Không đau hoặc, giảm đau trong lúc nghỉ.
- Giảm đau trong lúc hoạt động.

3.2.2. Điều trị nội khoa

Sử dụng các thuốc kháng viêm giảm đau thông thường (paracetamol), các thuốc giảm đau dạng opioid yếu (cocain), các thuốc opioid dạng uống hoặc tiêm (morphin), các thuốc phối hợp (an thần, gây ngủ, thuốc chống trầm cảm...).

- Nguyên tắc sử dụng thuốc chống đau trong ung thư:
 - +Chọn thuốc phù hợp với mức độ đau.
 - +Không dùng các thuốc opioid ngay từ đầu.

+Dùng các thuốc giảm đau không opioid có tác dụng ngắn trước và phải phối hợp các thuốc.

+Các thuốc có opioid dùng sau cùng.

+Đường uống được ưu tiên lựa chọn, đường tiêm (bắp, tĩnh mạch) giảm đau chỉ định trong những trường hợp đau cấp tính.

+Truyền tĩnh mạch duy trì thuốc chống đau phải chuẩn độ bằng bơm tiêm tự động.

+Phải lưu ý tới các dụng phụ của thuốc chống đau, đặc biệt lưu ý chức năng bài tiết của thận.

+Phải có sự hợp tác tốt của bệnh nhân và gia đình để kiểm soát liều lượng thích hợp và theo dõi các tác dụng không mong muốn của thuốc giảm đau.

– Phác đồ điều trị đau từng bước theo mức độ đau của WHO:

+Bậc 1: Thuốc chống đau không có opioid, có hoặc không kết hợp với thuốc chống viêm không đặc hiệu, có hoặc không kết hợp với thuốc hỗ trợ đồng giảm đau.

+Bậc 2: Thuốc có opioid dạng yếu, opioid yếu dạng phối hợp, có hoặc không kết hợp với thuốc chống viêm không đặc hiệu, có hoặc không kết hợp với thuốc hỗ trợ đồng giảm đau.

+Bậc 3: Thuốc chống đau dạng opioid đường uống hoặc tiêm, có hoặc không kết hợp với thuốc chống viêm không đặc hiệu, có hoặc không kết hợp với thuốc hỗ trợ đồng giảm đau.

– Các thuốc giảm đau:

+Nhóm thuốc không opioid:

- Acetaminophen: paracetamol uống, người lớn 0,5-1g/lần, trẻ em 10-15mg/kg, mỗi 4-6 giờ/lần. Người lớn, đau nhiều, cấp tính dùng 1g/lần, truyền tĩnh mạch. Lưu ý tác dụng độc với gan. Liều tối đa cho người lớn: 4.000mg/ngày.
- Thuốc kháng viêm giảm đau không steroid (NSAIDs) có nhiều loại: diclofenac, meloxicam, ketorolac...
- Đường uống: Mobic 7,5mg x 2 viên ngày chia 2 lần, diclofenac 50mg x 2 viên ngày chia 2 lần. Acorxia 90mg uống 1 lần trong ngày.
- Đường tiêm: Voltaren 75mg, feldene 20mg tiêm bắp 1 ống/lần/ngày 1-2 lần. Cần lưu ý tác dụng phụ gây viêm loét dạ dày và giảm tiểu cầu nếu dùng kéo dài.

+Nhóm thuốc opioid:

- Opioid yếu dạng phối hợp (Tramadol + paracetamol, codein + paracetamol): Ultracet (Tramadol 37,5mg + paracetamol 325mg): liều 1 đến 2 viên mỗi 4 đến 6 giờ, tối đa 8 viên/ngày. Ultracet có thể uống mà không cần quan tâm đến thức ăn, có thể dùng trong cơn đau đột xuất trong đau ung thư.

- Codein: Liều người lớn 30-60mg/lần, trẻ em 0,5-1mg/kg. Dùng liên tục 3-4 giờ/lần.
- Tramadol: Liều người lớn 50-100mg/lần. Dùng mỗi 4-6 giờ/lần, liều tối đa 400mg/ngày.

+Nhóm thuốc opioid mạnh:

- Morphin: Nguyên tắc dùng phải dò liều, dùng liều thấp và tăng dần, không cho liều đột xuất. Đường uống: viên 10, 20, 30mg, liều khởi đầu 10mg sau đó điều chỉnh tăng dần theo độ đau. Morphin tiêm dưới da hoặc tiêm bắp: ống 10mg x 1 ống/lần/ngày 1-2 lần, điều chỉnh liều theo độ đau. Sử dụng morphin 10mg, 30mg đường uống, giải phóng kéo dài (MSContin 10, 30mg), sử dụng 12 giờ/lần, bệnh nhân thường có cơn đau nặng, không kiểm soát được bằng các opioid yếu hơn (ví dụ dihydrocodeine), thường dùng với liều khởi đầu 30mg mỗi 12 giờ.
- Fentanyl: Dùng phải dò liều, dùng liều thấp và tăng dần, không cho liều đột xuất. Fentanyl dạng miếng dán qua da (biệt dược Durogesic): miếng dán da ngực hoặc mặt trong đùi, mặt ngoài cánh tay, phóng thích 25mcg/giờ và 50mcg/giờ; tác dụng kéo dài 72 giờ. Giảm đau trong các trường hợp đau mạn tính, đau dai dẳng đòi hỏi sử dụng opioid dài ngày. Liều dùng: Người lớn: Bệnh nhân chưa dùng opioid: kinh nghiệm sử dụng opioid còn giới hạn. Nên sử dụng opioid tương đương 135mg morphin uống/ngày rồi chuyển qua Durogesic 25mcg/giờ. Bệnh nhân đã dùng nạp opioid: tính liều Durogesic cần dùng theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng liều của thuốc giảm đau opioid trước đó trong 24 giờ.

Bước 2: Quy đổi thành liều morphin uống theo bảng 1.

Bước 3: Quy đổi thành liều Durogesic cần dùng theo bảng 2.

Trẻ em: Durogesic chỉ được dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, đã dùng nạp opioid, tổng liều opioid tương đương ≥ 30 mg morphin uống mỗi ngày. Cách tính liều tương tự người lớn.

Chuẩn liều và điều trị duy trì: Do sự gia tăng từ từ nồng độ thuốc trong huyết thanh nên trong 12-24 giờ của miếng dán đầu tiên, bệnh nhân nên duy trì sử dụng thuốc giảm đau khác trước đó. Miếng dán Durogesic nên được thay thế mỗi 72 giờ. Liều nên đánh giá và điều chỉnh cho từng bệnh nhân cho đến khi đạt được hiệu quả giảm đau sau 3 ngày. Mỗi lần gia tăng hàm lượng 25mcg/giờ. Bệnh nhân có thể cần dùng thêm các thuốc giảm đau tác động ngắn từng thời kỳ cho các cơn đau bộc phát. Một vài bệnh nhân có thể dùng thêm các phương pháp bổ sung hoặc thay thế chỉ định opioid khi liều Durogesic vượt quá 300mcg/giờ. Khi ngưng thuốc đột ngột có thể xảy ra hội chứng cai thuốc. Do đó khi cần ngưng thuốc nên giảm liều dần.

Bảng 1. Quy đổi thành liều morphin uống

Tên thuốc	Liều tương đương (mg)	
	Tiêm bắp (mg)	Uống
Morphin	10	30 (áp dụng đối với liều lặp đi lặp lại) 60 (áp dụng cho liều duy nhất)
Hydromorphone	1,5	7,5
Methadone	10	20
Oxycodone	15	30
Codein	130	200

Bảng 2. Liều Durogesic khuyến dùng dựa trên liều morphin uống/ 24 giờ

Morphin uống 24 giờ (mg/ngày)	Durogesic (mcg/giờ)	Morphin uống/24 giờ (mg/ngày)	Durogesic (mcg/giờ)
30-40 (cho trẻ em)	12	495-584	150
45-134 (cho trẻ em)	25	585-674	175
<135 (cho người lớn)	25	675-764	200
135-224	50	765-854	225
225-314	75	855-944	250
315-404	100	945-1034	275
405-494	125	1.035-1.124	300

Fentanyl dạng truyền tĩnh mạch: Điều trị đau kịch phát liều 0,5-1mcg/kg tiêm, truyền tĩnh mạch liên tục liều 25-100mcg/giờ.

– Hoặc có thể dùng oxycodone: Phải dùng dò liều, dạng tác dụng nhanh (IR): Oxycodone 5mg (Oxyneo 5mg), dạng tác dụng kéo dài (ER): oxycodone 10mg, 15mg, 20mg, 30mg (Oxycontin 10, 15, 20, 30mg):

+Bắt đầu dùng liều điều trị với oxycodone liều 10mg mỗi 12 giờ, sử dụng viên oxycodone (Oxycontin) giảm đau liên tục 12 giờ, liều nên được tăng 25-50% khi cần thiết đến khi đạt được hiệu quả kiểm soát.

+Sử dụng oxycodone 5mg (Oxyneo 5mg) mỗi 4-6 giờ khi cần cho đau đột xuất. Liều đột xuất nên tương đương với 1/6 tổng liều oxycodone hàng ngày.

+Nếu bệnh nhân cần cứu hộ hơn 2 lần 1 ngày thì liều oxycodone nên được tăng lên.

– Oxycodone/Naloxone: 5-2,5mg, 5-10mg, 20-10mg, 40-20mg (Targinact 5-2,5mg, 5-10mg, 20-10mg, 40-20mg). Thành phần naloxone đối kháng opioid được bổ sung nhằm giảm tác dụng gây táo bón của opioid bằng cách ức chế tác động của oxycodone tại các thụ thể opioid trong đường tiêu hóa.

– Các thuốc hỗ trợ:

+Corticosteroid: hydrocortisol: viên medrol 16mg x uống 2 viên ngày. Tiêm, truyền tĩnh mạch methylprednisolon 40mg x 1-2 lần ngày.

+Nhóm thuốc chống trầm cảm: amitriptylin, nortriptylin. Viên Apo-Amitriptyline 25mg uống 1-2 viên/ngày.

+Thuốc chống co giật: carbamazepin viên 200mg uống 1-2 lần/ngày/ mỗi lần 1 viên. Gabapentin 150mg uống lần 2 viên x 2-3 lần ngày, liều tối đa 3.600mg/ngày. Pregabalin viên 75mg, uống lần 1 viên x 2 lần/ngày.

+Thuốc chống co thắt cơ trơn: Buscopan, spasfon viên 40mg uống 1-2 viên/lần/ngày uống 1-2 lần; ống 20mg tiêm bắp 1 ống/lần/ngày x 1-2 lần. Nospa viên 40mg uống 1-2 viên/lần/ngày x 1-2 lần, ống 40mg tiêm bắp 1 ống/lần/ngày x 1-2 lần.

+Thuốc an thần, giãn cơ: diazepam viên 5mg uống ngày 1-2 viên, ống 10mg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch 1 ống/ lần.

+Thuốc chống hủy xương: biphosphonat 90mg hoặc acid zoledronic 4mg truyền tĩnh mạch 21-28 ngày/lần, trong trường hợp đau do ung thư di căn xương.

3.2.3. Phẫu thuật

Có thể là phẫu thuật tạm thời, dẫn lưu, nối tắt, chỉnh hình, cắt bỏ một phần khối u và các tổn thương di căn trong những trường hợp không thể phẫu thuật triệt căn, phẫu thuật cắt đường thần kinh dẫn truyền đau nếu định khu được.

3.2.4. Xạ trị chiếu ngoài chống đau do ung thư

– Là phương thức điều trị hiệu quả cho đau do ung thư xương nguyên phát hoặc di căn.

– Xạ trị chiếu ngoài bằng máy gia tốc: thường dùng liều xạ trị: 2Gy x 20 buổi hoặc 3Gy x 10 buổi hoặc 4Gy x 5 buổi.

3.2.5. Điều trị chống đau do ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ

– Là phương thức xạ trị chuyển hóa bằng đồng vị phóng xạ nguồn hữ: áp dụng được cho cả các trường hợp ung thư di căn xương nhiều ổ.

– Các thuốc phóng xạ hướng xương dùng điều trị chống đau do ung thư là:

+Phospho-32 (^{32}P) uống hoặc tiêm tĩnh mạch liều 1-1,5mCi/10kg cân nặng cho một lần điều trị.

+Samarium-153 (^{153}Sm), truyền tĩnh mạch liều 1-3mCi/1kg cân nặng.

+Strontium-89 (^{89}Sr) liều 0,05-1mCi/1kg cân nặng, truyền tĩnh mạch.

– Thuốc phóng xạ chỉ định dùng khi bệnh nhân có chẩn đoán xác định là ung thư di căn xương.

Lưu ý: Theo dõi tác dụng phụ ức chế tủy xương gây thiếu máu, hạ bạch cầu, hạ tiểu cầu để điều trị các biến chứng này kịp thời.

3.2.6. Điều trị giảm đau bằng máy Sacobe

Đây là máy sử dụng xung điện với tần số phù hợp để tác động vào các đầu mút cảm nhận của dây thần kinh cảm giác chi phối vùng, nhằm làm thay đổi tín hiệu nhận cảm của các dây thần kinh trở về, làm cho bệnh có cảm giác tê hoặc đỡ đau.

4. TIỀN LƯỢNG

Phụ thuộc vào mức độ đau, nguyên nhân đau.

Đau không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến chất lượng sống, tâm lý, sinh hoạt của bệnh nhân.

5. THEO DÕI

Để theo dõi đau, cần phải có đánh giá đau.

Đau là cảm giác chủ quan của bệnh nhân và đau phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cường độ, thể loại tác nhân gây đau, vị trí tổn thương và ngưỡng chịu đựng của mỗi cá thể nên khó có thể ghi nhận, đánh giá hoặc đo mức độ đau bằng các kỹ thuật xét nghiệm cũng như thăm dò chức năng.

Để đánh giá đau trên lâm sàng áp dụng các phương pháp sau:

- Hỏi bệnh: phải tạo cho bệnh nhân có trạng thái tâm lý tốt, hợp tác và trả lời chính xác các câu hỏi do thầy thuốc đặt ra để xác định được bệnh nhân có đau hay không, vị trí đau, tính chất đau và mức độ đau nhẹ vừa hay nặng.

- Khám bệnh: phát hiện các triệu chứng của đau, lý do đau như thay đổi nhiệt độ, co cứng, thay đổi mạch, huyết áp, nhịp thở, dấu hiệu phù nề, viêm loét, chèn ép, tắc nghẽn...

- Đánh giá mức độ đau:

- +Thước đo hiển thị số (Visual Analogue Scale: VAS): thước đo được chia thành 10 điểm từ 0 đến 10 (0 điểm: không đau, 10 điểm: là mức độ đau mà bệnh nhân không chịu đựng nổi). Bệnh nhân được hướng dẫn để tự chấm điểm đánh giá mức độ đau.

- +Thước đánh giá tỷ lệ hiển thị số (Numerical Rating Scale: NRS): thước đo được chia thành 100 điểm từ 0 đến 100 (0 điểm: không đau, 100 điểm: là mức độ đau mà bệnh nhân không chịu đựng nổi). Bệnh nhân được hướng dẫn để tự chấm điểm đánh giá mức độ đau từ 0 đến 100. Ưu điểm: thước dễ sử dụng, ít sai số vì tỷ lệ chia thang điểm nhỏ chỉ bằng 1/10 của thước VAS.

- +Mức độ đau theo bậc thang của WHO: đau được chia thành 3 bậc: 1, 2 và 3 tương ứng đau nhẹ, đau vừa và đau nặng theo mức độ điều trị và kiểm soát đau. Đây là cách đánh giá đau có ý nghĩa lâm sàng và thực tiễn nhất. Phương pháp này dễ thực hiện và thuận tiện cho người thầy thuốc trong việc đánh giá và kiểm soát đau trong ung thư.

Bảng 3. Lượng hóa mức độ đau khi kết hợp các phương thức đánh giá

Theo WHO	Theo Serlin, Nakamura	Theo thang điểm VAS
Bậc 1	Đau nhẹ	1-4 điểm
Bậc 2	Đau vừa	5-7 điểm
Bậc 3	Đau nặng	8-10 điểm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010). Điều trị nội khoa bệnh ung thư. Nhà xuất bản Y học.
2. Mai Trọng Khoa (2014). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu. Nhà xuất bản Y học.
3. Trần Văn Thuấn, Lê Văn Quảng, Nguyễn Tiến Quang (2019). Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh ung thư thường gặp. Nhà xuất bản Y học.
4. Bùi Diệu và cs (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư thường gặp. Nhà xuất bản Y học.
5. Mai Trọng Khoa, Nguyễn Xuân Kỳ (2012). Một số tiến bộ về kỹ thuật xạ trị ung thư và ứng dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
6. Mai Trọng Khoa và cộng sự (2012). Y học hạt nhân (Sách dùng cho sau đại học). Nhà xuất bản Y học.
7. Gia Cường (2001). Đau. Nhà xuất bản Y học.
8. Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff, Charles A. Koller (2006). The MD Anderson manual of medical oncology. McGraw - Hill.
9. National Comprehensive Cancer Network (2019). Adult cancer pain, version 3.2019. NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology.
10. Vincent T DeVita, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg (2014). Cancer Principles and Practice of Oncology, 10th edition. Lippincott Ravell publishers. Philadelphia, United.
11. Oxycontin Prescribing information Viet Nam (2015).

DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ

1. ĐẠI CƯƠNG

Ung thư là một bệnh mạn tính, từ cơ quan bị bệnh có thể di căn đến các vị trí khác, gây ra nhiều biến chứng, có tác động xấu đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh.

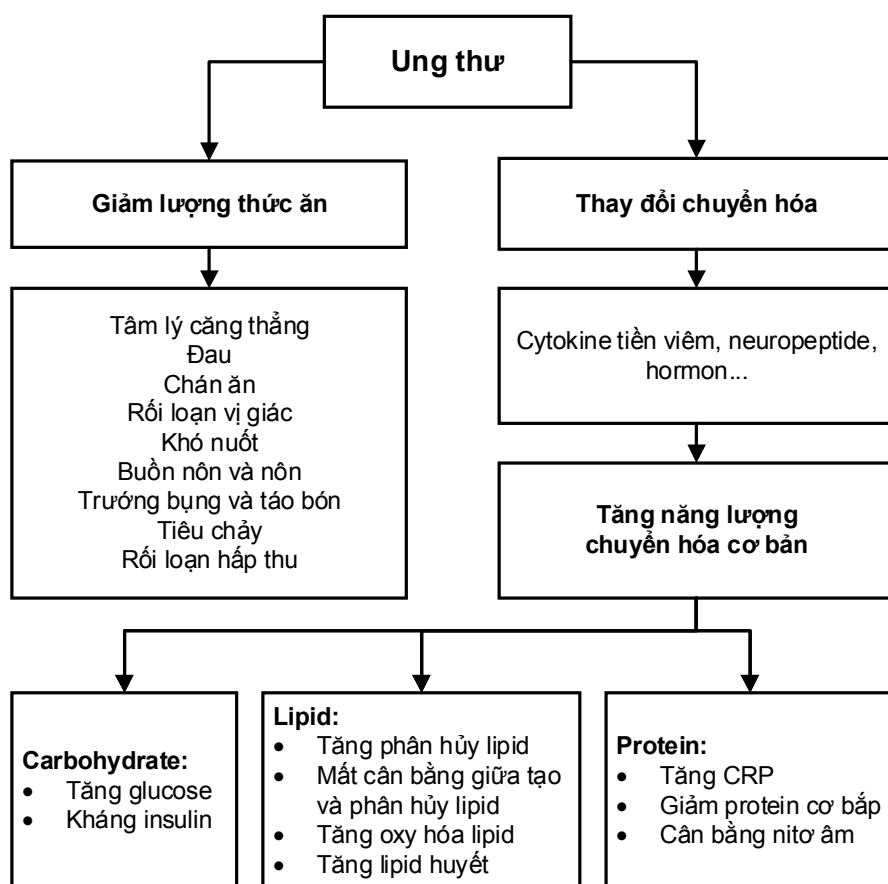
Ung thư ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng và ngược lại, tình trạng dinh dưỡng kém cũng ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị, cách thức điều trị và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư. Trên thực tế, có đến 20% người bệnh ung thư tử vong do suy dinh dưỡng chứ không phải chỉ do bệnh ung thư.

Can thiệp dinh dưỡng sớm cho người bệnh ung thư giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, duy trì cân nặng, duy trì khối nạc cơ thể, đáp ứng tốt với điều trị, đặc biệt cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Chính vì vậy, dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong chăm sóc và điều trị bệnh ung thư kể từ khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh cho đến suốt cả cuộc đời sau đó.

2. CHẨN ĐOÁN SUY DINH DƯỠNG VÀ SUY MÒN TRONG UNG THƯ

2.1. Mối liên quan giữa suy dinh dưỡng, suy mòn và bệnh ung thư

Khi xuất hiện 1 tế bào bất bình thường (tế bào ung thư) cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tăng sản sinh các yếu tố dị hóa đặc hiệu làm phân hủy các khối cơ và khối mỡ của cơ thể, đồng thời tăng sản sinh các yếu tố miễn dịch điều này khiến cho cơ thể bị mất cảm giác thèm ăn, rối loạn chuyển hóa các nhóm chất chính như đạm, đường, chất béo. Không những thế, khối u còn làm tăng tiêu hao năng lượng, ngay cả khi bệnh nhân nghỉ ngơi, không hoạt động cũng sẽ mất một lượng calo rất lớn. Các yếu tố trên chính là nguyên nhân tiềm ẩn thực sự dẫn đến suy mòn trong ung thư.



Suy dinh dưỡng được định nghĩa là tình trạng dinh dưỡng trong đó thừa hoặc thiếu (hoặc không cân đối) năng lượng, protid và các chất dinh dưỡng khác gây ra các ảnh hưởng trên mô và cơ thể cũng như các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng. Trong ung thư, suy dinh dưỡng có thể là kết quả của quá trình mắc bệnh, từ liệu pháp điều trị hoặc cả hai. Tác dụng phụ liên quan đến liệu pháp điều trị ung thư gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch, đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy tình trạng dinh dưỡng.

Suy mòn ung thư được định nghĩa là một hội chứng đặc trưng bởi sự mất liên tục khối cơ xương (có hay không có kèm mất khối mỡ) mà nó sẽ không được hồi phục hoàn toàn bởi sự hỗ trợ dinh dưỡng thông thường, diễn tiến đến suy chức năng. Tỷ lệ suy mòn trong các nhóm bệnh nhân ung thư khác nhau từ 8% đến 84% phụ thuộc vào từng loại ung thư cụ thể, ví dụ 80% suy mòn do ung thư đường tiêu hóa và 70% suy mòn ở bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ. Sự giảm khối lượng cơ do ung thư thường được coi là một sự thích nghi sinh lý: sự hy sinh phần lớn khối lượng cơ bắp của cơ thể để bù đắp protein cho các tạng giữ các chức năng quan trọng.

Tình trạng sụt cân dẫn đến suy mòn trong ung thư được xác định do hai nguyên nhân chính:

- Giảm lượng thức ăn
- Thay đổi chuyển hóa

Sụt cân, suy dinh dưỡng và suy mòn có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị của người bệnh ung thư:

- Tăng độc tính của các liệu pháp điều trị
- Giảm đáp ứng với điều trị
- Tăng thời gian các đợt nằm viện và tỷ lệ tái nhập viện
- Tăng các biến chứng nhiễm trùng
- Giảm chất lượng sống
- Cảm giác suy sụp, mệt mỏi

Do đó người bệnh ung thư cần được phát hiện sớm các dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng và can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

2.2. Chẩn đoán suy dinh dưỡng và suy mòn

2.2.1. Tiêu chí chẩn đoán suy dinh dưỡng

Chẩn đoán là suy dinh dưỡng khi người bệnh có một trong các dấu hiệu sau:

- Sụt cân >5% trong 6 tháng qua
- Hoặc BMI <20kg/m² và bất kỳ sụt cân >2%
- Hoặc chỉ số cơ xương chi phù hợp với giảm khối nạc (sarcopenia) (nam <7,26kg/m²; nữ <5,45kg/m²) và bất kỳ sụt cân >2%.

2.2.2. Các xét nghiệm đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư

- Định lượng albumin huyết thanh.

+Bình thường người lớn là 35-48gam/lít. Lượng albumin <35gam/lít được coi là thấp (suy dinh dưỡng), trong đó:

- +Albumin 30-35 gam/lít: suy dinh dưỡng mức độ nhẹ
- +Albumin 21-<30 gam/lít: suy dinh dưỡng mức độ trung bình
- +Albumin <21 gam/lít: suy dinh dưỡng mức độ nặng
- Định lượng protein toàn phần
 - +Protein toàn phần: 60-80 gam/lít là bình thường
 - +Protein toàn phần <60 gam/lít là thấp.

- Đánh giá tình trạng thiếu máu dựa vào số lượng hồng cầu, huyết sắc tố:

Hồng cầu: Bình thường nữ >3,8T/l, nam >4,2T/l.

- +Từ 3-3,8T/l với nữ, 4,2T/l với nam là thiếu máu nhẹ
- +Từ 2-3T/l thiếu máu nặng
- +Hồng cầu <2T/l thiếu máu nặng.

Huyết sắc tố: Bình thường nữ >130G/L, nam >140G/L.

- +Từ 90-130G/L thiếu máu nhẹ

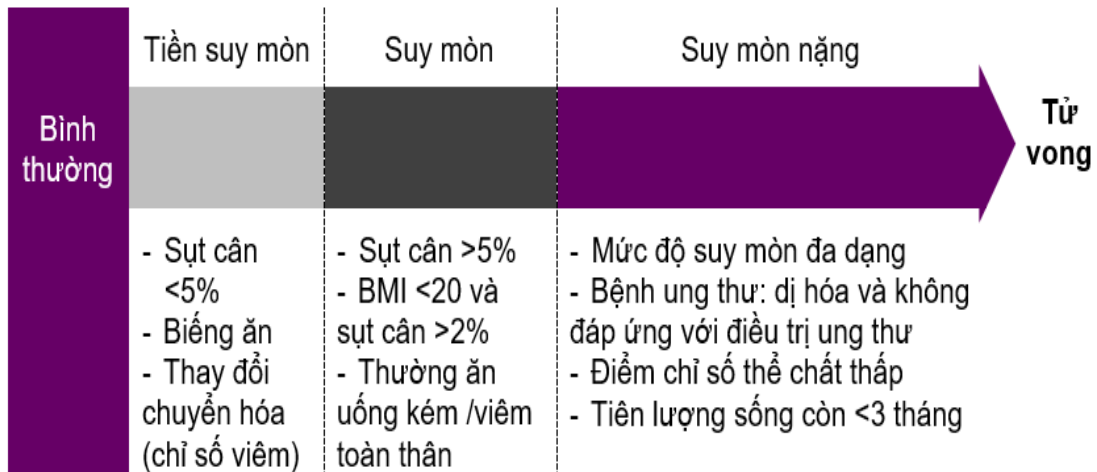
- +Từ 60-90G/L thiếu máu vừa
- +Huyết sắc tố <60G/L thiếu máu nặng
- Đánh giá tình trạng đáp ứng miễn dịch dựa vào số lượng lympho bào.

Bạch cầu lympho có chức năng chính là tham gia các đáp ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể.

- +Từ 1,2-2G/L suy dinh dưỡng mức độ nhẹ
- +Từ 0,8-1,2G/L suy dinh dưỡng mức độ vừa
- +<0,8G/L suy dinh dưỡng mức độ nặng
- Các xét nghiệm: Số lượng hồng cầu; Huyết sắc tố; Bạch cầu lympho có thể thay đổi do tác dụng phụ của liệu pháp điều trị. Do vậy, nó không đặc hiệu nên không được khuyến cáo sử dụng đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh ung thư.

2.2.3. Các giai đoạn của suy mòn được xác định như sau

- Tiền suy mòn
- Suy mòn
- Suy mòn nặng



Suy mòn do ung thư thường biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng ở giai đoạn tiến triển (với mất khối cơ, sụt cân, giảm hoạt động thể chất. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cơ hội phục hồi bệnh nhân thành công đã không còn. Y học hiện đại đã nhận ra rằng suy mòn tiến triển qua các giai đoạn khác nhau: tiền suy mòn, suy mòn, suy mòn nặng và đang hướng sự tập trung điều trị suy mòn ngay từ thời điểm chẩn đoán ung thư. Ở giai đoạn đầu - tiền suy mòn, bệnh nhân mới có ít dấu hiệu như chán ăn, sụt cân nhẹ (<5% thể trọng ban đầu) thì thường có xu hướng không được quan tâm vì cho là một mối bình thường. Ở giai đoạn tiếp theo, suy mòn thực sự - người bệnh thường xuyên giảm ăn vào, sụt cân nhiều (>5% thể trọng), rối loạn chuyển hóa toàn thân. Giai đoạn cuối, suy mòn

nặng - cơ thể suy kiệt, không đáp ứng với các điều trị. Thời gian sống của người bệnh thường ngắn, nhiều khi khó có thể kéo dài quá 3 tháng.

3. DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

3.1. Mục tiêu dinh dưỡng trong điều trị ung thư

- Ngăn ngừa hoặc điều chỉnh thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân hay mất khối nạc của cơ thể.
- Đạt và duy trì được cân nặng cơ thể ở mức tối ưu.
- Tăng khả năng dung nạp với các điều trị ung thư.
- Giảm hoặc ngăn ngừa được các tác dụng phụ trong quá trình điều trị.
- Cải thiện hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
- Giúp cơ thể hồi phục nhanh và chóng lành vết thương.
- Cải thiện tiên lượng và tăng khả năng phục hồi của cơ thể.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư.

3.2. Nhu cầu dinh dưỡng trong điều trị ung thư

- Năng lượng: Tiêu thụ năng lượng ở bệnh nhân ung thư rất lớn, trung bình khoảng 30-35 Kcal/kg/ngày. Một số trường hợp đặc biệt có thể cần tới 40-50 Kcal/kg/ngày.
- Protein: 15-20% tổng năng lượng. Protein động vật chiếm 30%-50% tổng số protein, đặc biệt các acid amin leucine, glutamine, arginine, HMB.
- Lipid: 18-25% tổng năng lượng trong đó: 1/3 acid béo no, 1/3 acid béo không no một nối đôi, 1/3 acid béo không no nhiều nối đôi. Omega 3 (EPA: 2g/24 giờ,...) MCT/MUFA/PUFA.
- Glucid: 60-70% tổng năng lượng.
- Vitamin, khoáng chất và chất xơ: theo nhu cầu của người bình thường khỏe mạnh.
- Nước: 40ml/kg cân nặng/ngày (35ml/kg cân nặng ở người cao tuổi).
- Muối: không quá 6g/ngày.

3.3. Chỉ định đường nuôi dưỡng trong điều trị ung thư

- Cần lựa chọn đường nuôi dưỡng theo thứ tự các bước như sau:

Bước 1	Bước 2	Bước 3	Bước 4
Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa (EN)	Một phần EN + 1 phần dinh dưỡng tĩnh mạch (PN)	PN + EN tối thiểu	Dinh dưỡng hoàn toàn qua tĩnh mạch

Tùy đặc điểm của bệnh, phương pháp và giai đoạn điều trị có chỉ định dinh dưỡng khác nhau.

Trong điều trị ung thư, cả 2 đường nuôi dưỡng: đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch đều được áp dụng.

– Dinh dưỡng đường miệng là quan trọng nhất và cần được quan tâm ngay từ đầu cũng như suốt quá trình điều trị. Dạng chế biến nuôi đường tiêu hóa cũng rất đa dạng chỉ định tùy thuộc vào người bệnh, và đặc điểm bệnh. Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng thông thường (đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng và chất xơ) theo nhu cầu cho người bệnh ung thư thì cần bổ sung thêm các chất cần thiết tăng cường hồi phục và chống tiêu cơ như: leucine, glutamine, arginine, HMB, EPA, MCT/MUFA/PUFA.

– Dinh dưỡng tĩnh mạch: Đa số các bệnh nhân ung thư đều có chán ăn, hấp thu kém vì vậy ngoài việc bổ sung dinh dưỡng đường miệng thì bổ sung dinh dưỡng đường tĩnh mạch là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần chú ý, dinh dưỡng tĩnh mạch cần đầy đủ các chất: đạm, đường, béo, vitamin và muối khoáng theo nhu cầu.

+Các dung dịch dinh dưỡng tĩnh mạch thường dùng:

- Cung cấp carbohydrat (Glucid): 1g dextrose cho 3,4 Kcal. 1g glucose cho 4 Kcal.
- Cung cấp protein (Acid amin): 1g cho 4Kcal.

Cho người bệnh có chức năng gan thận bình thường: alversin; moriamin; vaminolact;...

Cho người bệnh suy thận: kidmin; nephrosteril...

Cho người bệnh suy gan: hepagold, aminoleban...

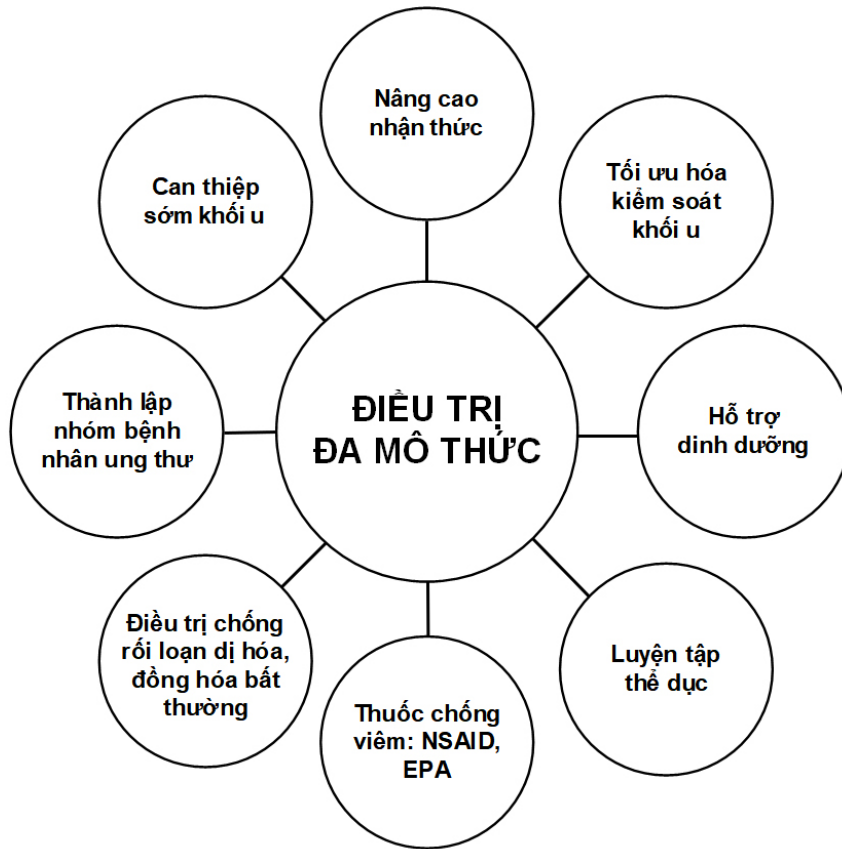
- Cung cấp lipid: lipofundin; smoflipid; clinoleic... 1g cho 9 Kcal.
- Nhóm hỗn hợp: 3 trong 1: Combilipid; kabiven; nutriflex lipid; oliclinomel... 2 trong 1: Nutriflex...
- Cung cấp vitamin: tamipool, cernevit.
- Cung cấp chất khoáng: decan; MTE -5.

+Bổ sung dinh dưỡng đường tĩnh mạch cần kiểm tra xét nghiệm máu (protein, albumin, pre-albumin, cholesterol, triglyceride, ure, creatinin, GOT, GPT...) sau 1-2 tuần để theo dõi và điều chỉnh dịch truyền cho phù hợp. Với bệnh nhân suy mòn, nhất là suy mòn nặng có thể kiểm tra pre-albumin 3 ngày/1 lần.

3.4. Điều trị dinh dưỡng cho suy mòn

Cơ chế gây suy mòn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, do vậy phác đồ điều trị cũng là phác đồ điều trị tổng hợp, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Khuyến cáo từ Hội Dinh dưỡng đường tĩnh mạch và Tiêu hóa Hoa Kỳ (ASPEN); Hội Dinh dưỡng đường tĩnh mạch và Tiêu hóa châu Âu (ESPEN) đều thống nhất:

- Nên can thiệp sớm, đặc biệt ở giai đoạn tiền suy mòn và suy mòn.
- Điều trị đa mô thức (phối hợp nhiều phương pháp điều trị):



Khởi đầu: Năng lượng thấp: 10-20 Kcal/cân nặng/ngày. Với bệnh nhân suy mòn nặng thì liều khởi đầu càng thấp. Sau đó tăng dần theo kịp nhu cầu của bệnh nhân ung thư. Chú ý bổ sung đầy đủ các vitamin, chất khoáng. Điều chỉnh cân bằng nước và điện giải. Theo dõi sát điện giải đồ, glucose và pre-albumin máu.

Bổ sung sản phẩm giàu EPA (>2g EPA/ngày) có tác dụng làm giảm sự sản xuất các chất gây viêm, giảm các xáo trộn chuyển hóa trong hội chứng suy mòn giúp ổn định cân nặng, cải thiện tình trạng chán ăn. EPA được bổ sung thông qua các sản phẩm như: mỡ cá, viên dầu cá hoặc sản phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư.

Theo nghiên cứu đưa ra việc bổ sung dinh dưỡng bằng đường miệng cho đáp ứng tốt nhất vào giai đoạn tiền suy mòn và suy mòn. Ở giai đoạn suy mòn nặng việc đáp ứng với dinh dưỡng qua đường miệng trở nên thấp, nên tùy theo bệnh nhân cần được can thiệp dinh dưỡng đường ruột (qua sonde) hoặc đường tĩnh mạch càng sớm càng tốt.